

TEMA 6.15 • INFECTOLOGÍA

Exantemas – Segunda Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Exantemas Infecciosos — Parte II

Síndrome Pie-Mano-Boca

- **Agente:** Enterovirus **Coxsackievirus A16**
- **Edad:** Escolares y preescolares (> 3 años)
- **Clínica:**
 - - Vesículas en manos (palmas **y** dorso) y pies (plantas **y** dorso)
 - - Enantema vesiculoso en paladar y mucosa oral
 - - Fiebre leve
- **Diagnóstico:** Clínico.
- **Tratamiento:** Sintomático.
 - > Mismas vesículas en palmas y plantas, pero:
 - > - Niño escolar → Pie-mano-boca
 - > - Adulto → Sífilis secundaria
 - > - Lactante muy pequeño → Sarna (escabiosis)

Escarlatina

- **Agente:** *Streptococcus pyogenes* (Grupo A) → produce **toxina eritrogénica**
- **Edad:** Escolares y adultos (> 3 años)
- **Clínica específica:**
 - - Exantema finamente papular ("piel de gallina") que respeta el triángulo de Filatov (zona peribucal)
 - - **Lengua en fresa roja** → luego **lengua en fresa blanca** (puntitos rojos sobre fondo blanco)
 - - **Líneas de Pastia:** Petequias lineales en pliegues cubitales (fosas antecubitales)
 - - De base: amigdalitis bacteriana (escarlatina faríngea)
- **Diagnóstico:** Clínico.
- **Tratamiento:**
 - - Faríngea: igual que amigdalitis → Penicilina Benzatínica IM o Amoxicilina × 10 días
 - - **Quirúrgica** (fuente piel/herida → más grave, riesgo de shock tóxico): Penicilina G EV + **Clindamicina** (disminuye producción de toxinas)

Meningococemia

- Meningococo (N. meningitidis) puede producir bacteremia sin meningitis.
- **Clínica característica:** Fiebre + exantema **petequeial-purpúrico** que no desaparece a la vitropresión (fenómeno no blanqueable).
- **Urgencia vital** → Ceftriaxona EV de inmediato (sin esperar PL si hay inestabilidad).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 5 años consulta por vesículas dolorosas en palmas, plantas y úlceras en el paladar blando, con fiebre de 37,8°C. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Exantemas - Segunda Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Síndrome pie-mano-boca (Coxsackie A16): escolares, exantema papulovesicular doloroso en manos, pies y boca (enantema en paladar). Diagnóstico clínico, tratamiento sintomático.
- Mismas lesiones en palmas/plantas según edad: escolares = pie-mano-boca, adultos = sífilis secundaria, lactantes = sarna.
- Escarlatina (estreptococo grupo A + toxina eritrogénica): exantema en piel de gallina, respeta triángulo de Filatov, lengua en fresa roja/blanca, líneas de Pastia en fosas cubitales.
- Escarlatina faríngea: sobre amigdalitis pultácea, tratamiento con penicilina/amoxicilina. Escarlatina quirúrgica: más grave, penicilina G EV + clindamicina (riesgo shock tóxico).
- La clindamicina se agrega en cuadros graves para disminuir producción y liberación de toxinas estreptocócicas.
- Meningococemia: exantema petequeial/purpúrico por Neisseria meningitidis, puede evolucionar a púrpura fulminante. Tratamiento antibiótico urgente.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EXANTEMAS - SEGUNDA PARTE)**PREGUNTA 1**

Niño de 5 años consulta por vesículas dolorosas en palmas, plantas y úlceras en el paladar blando, con fiebre de 37,8°C. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Varicela
- B)** Sífilis secundaria
- C)** Síndrome pie-mano-boca
- D)** Herpes simple diseminado
- E)** Escarlatina

PREGUNTA 2

Niño de 7 años con amigdalitis pultácea presenta exantema papular tipo piel de gallina que respeta la zona perioral, lengua roja con papilas prominentes, y petequias lineales en fosas cubitales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Tratamiento sintomático con paracetamol
- B)** Penicilina benzatina 1,2 millones IM o amoxicilina oral por 10 días
- C)** Penicilina G endovenosa más clindamicina
- D)** Aciclovir oral por 7 días
- E)** Ciprofloxacino oral por 7 días

PREGUNTA 3

Paciente de 20 años con herida operatoria infectada en muslo derecho desarrolla exantema en piel de gallina generalizado, fiebre alta e hipotensión. ¿Cuál es la complicación más temida y el tratamiento antibiótico adecuado?

- A)** Fascitis necrotizante; ceftriaxona endovenosa
- B)** Shock tóxico estreptocócico; penicilina G endovenosa más clindamicina
- C)** Sepsis por estafilococo; vancomicina endovenosa
- D)** Glomerulonefritis postestreptocócica; penicilina benzatina IM
- E)** Fiebre reumática; amoxicilina oral por 10 días

RESUMEN: EXANTEMAS - SEGUNDA PARTE

Esta clase continúa con los exantemas, abordando el síndrome pie-mano-boca, la escarlatina y la meningococcemia. El síndrome pie-mano-boca es causado por el virus Coxsackie A16, afecta escolares y preescolares, y se presenta con exantema papulovesicular doloroso en manos (palmas y dorso), pies (plantas y dorso) y enantema en paladar blando y boca. Las mismas lesiones en palmas y plantas en adultos sugieren sífilis secundaria, y en lactantes, sarna. La escarlatina es causada por *Streptococcus* grupo A productor de toxina eritrogénica. Afecta a mayores de 3 años. Se caracteriza por exantema en piel de gallina (tipo papular), respeta el triángulo de Filatov, enantema con lengua en fresa roja/blanca, líneas de Pastia (petequias lineales en fosas cubitales). De base hay una amigdalitis pultácea (escarlatina faríngea) o una infección cutánea (escarlatina quirúrgica, más grave). Tratamiento con antibióticos: penicilina/amoxicilina para la faríngea; para la quirúrgica, penicilina G endovenosa más clindamicina (riesgo de shock tóxico). La meningococcemia es causada por *Neisseria meningitidis* y se presenta con exantema petequeial/purpúrico que puede evolucionar a púrpura fulminante. Es de las pocas causas de exantema con petequias que requiere tratamiento antibiótico urgente.